



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ: 18/06/2025.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΚΙΑ: 78 ΑΜΚΑ: 13094701234
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Στεμνίτσα Αρκαδίας (Δ. Γορτυνίας). ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Οικία.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΑΘΗΣΗ: Πτώση εξ ιδίου ύψους.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ελεγχόμενη.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΘΗΣΗ: Πτώση εξ ιδίου ύψους, λόγω αναφερόμενου συγκοπητικού επεισοδίου. Κάταγμα ΔΕ ισχίου.

ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

A.Π.: 115 / 85 (mmHg)

SpO₂: 96 (%)

Θ: 36,9 (°C)

H.R.: 74 bpm

R.R.: 16 / min

G.C.S.: 15 / 15

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ασθενής τετρακινήτικός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από την οικία του (μετά από τηλεφωνική κλήση στις 14:45) στο ΤΕΠ του ΚΥ για διερεύνηση και αντιμετώπιση αναφερόμενης πτώσης εξ ιδίου ύψους, προ 30 λεπτών, ενώ έκτοτε αναφέρει έντονο άλγος στο ΔΕ ισχίο, καθώς και αδυναμία στήριξης και βάδισης στο σύστοιχο άκρο. Από την φυσική εξέταση διαπιστώθηκαν:

- **ΘΩΡΑΚΑΣ:** Χωρίς τραύματα, εκδορές ή μώλωπες από την πτώση. Δεν αναφέρει θωρακικό άλγος ή αναπνευστική δυσχέρεια. Αναπνευστικό ψιθύρισμα: κ.φ., ισότιμο. Χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από τον θώρακα και τους πνεύμονες.
- **ΚΑΡΔΙΑ:** S1, S2: βύθιοι, αλλά ακουστοί. Ήπιο ολοσυστολικό φύσημα, στον χώρο ακρόασης της Μιτροειδούς.
- **ΗΚΓ:** (επισυνάπτεται): SR, με έκτακτες κοιλιακές συστολές. Χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις.
- **ΚΟΙΤΙΑ:** Ελαφρώς διατεταμένη λόγω σωματότυπου. Δεν παρατηρούνται τραυματικές κακώσεις από την πτώση στο έδαφος. Μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη τόσο στην επιπολής όσο και στην εν τω βάθει ψηλάφηση. Ήπαρ, σπλήν, νεφροί: ψηλάφητοι και χωρίς ευαισθησία στην πίεση. Εντερικοί ήχοι: κ.φ., σε ένταση, χροιά και συχνότητα. Συνήθειες εντέρου: φυσιολογικές.
- **ΑΚΡΑ:** Τετρακινήτικός ασθενής, με ελάττωση της κίνησης - λόγω του έντονου άλγους - στο πάσχον ΔΕ κάτω άκρο. Μυϊκή ισχύς άκρων: φυσιολογική, ισότιμη, εκτός του τραυματισθέντος. Αναφέρει αρθροπλαστική ΑΡ. ισχίου προ 4 ετών.
- **ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ:** Χωρίς κακώσεις στην κεφαλή και την ΑΜΣΣ. Ασθενής προσανατολισμένος χωροχρονικά, συνεργάσιμος. Ελαφρώς διεγερτικός, λόγω του άλγους. Χωρίς εστιακή σημειολογία. Φωτοκινητικό αντανάκλαστικό (ΦΚΑ): Ισότιμο, κ.φ. Κόρες σε μέση θέση, άμφω.
- Λοιπά συστήματα: ελέγχονται κ.φ.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Dextro-stick: 122 (mg/dl).

- **Γεν. αίματος:** (Επισυνάπτεται): WBC: 8900 /μl (G/L: 68%/29%). Hgb: 13.2 mg/dl, Hct: 40.2%, PLT: 245000 /μl.
- **Βιοχημικά:** (Επισυνάπτεται): Glu: 125 mg/dl, Urea: 42 mg/dl, Creat: 1.24 mg/dl, ALT: 28 U/L, AST: 34 U/L, CRP: 0.3 mg/l.
- **Γενική ούρων:** (Επισυνάπτεται): Χωρίς παθολογικά ευρήματα.
- **Αέρια αίματος:** (Επισυνάπτονται): pH: 7.42, PaCO₂: 36 mmHg, PaO₂: 82 mmHg, HCO₃: 21 mEq/L, Lac: 1.8 mmol/L.
- **Ακτινογραφίες:** (Επισυνάπτεται CD): Υποκεφαλικό κάταγμα κεφαλής ΔΕ μηριαίου. Α/Α Θώρακος: κ.φ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

- 1000 ml N/S (στάγδην, για συντήρηση).
- 100 ml Aprotel 1 gr (εντός 15 λεπτών).
- 1 amp. Musco-Ril (im).
- 1 amp. Primperan, σε 100 ml N/S (εντός 15 λεπτών).
- 1 amp. Omeprazole (iv-bolus).
- Ουροκαθετήρας Foley 14 fr που απέδωσε αρχικά 300 ml διαυγή αχυρόχρωα ούρα και συνολικά 500 ml.
- _____
- _____
- _____
- _____

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- ΑΥ από 15ετίας, υπό φαρμακευτική αγωγή (Φ/Α), που ρυθμίζεται επαρκώς.
- Δυσλιπιδαιμία από 20ετίας, υπό Φ/Α, που ρυθμίζεται επαρκώς.
- Υπερουριχαιμία από 20ετίας, υπό περιστασιακή Φ/Α.
- Υποθυρεοειδισμός από 10ετίας (νόσος Hashimoto), υπό Φ/Α, με επαρκή ρύθμιση.
- ΓΟΠΝ από 15ετίας, υπό περιστασιακή Φ/Α με H₂ αναστολείς και PPIs.
- Δεν αναφέρει άλλα νοσήματα, χειρουργικές επεμβάσεις ή μείζονα ιατρικά συμβάντα στο ιστορικό του.
- Καπνιστής, 45 pack-years. Αναφέρει διακοπή του καπνίσματος εδώ και 2,5 χρόνια.

ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

- Micardis plus (80/12,5) mg, [1-0-0].
- Amlopen 5 mg, [0-0-1].
- Soluric 100 mg, [0-1-0].
- Medithyrox 75 mcg, [1-0-0].
- Pantium 40 mg, [1-0-0], περιστασιακά επί γαστρίτιδος.
- _____
- _____
- _____

ΕΠΙΚΡΙΣΗ

Ο ασθενής παρέμεινε στο ΤΕΠ του ΚΥ, για 30 λεπτά, για σταθεροποίηση. Παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός, με: ΑΤ: 121/88 mmHg, HR: 72 bpm, SpO₂: 98%, RR: 14/min, GCS: 15/15. Μερική ύφεση του άλγους στο πάσχον άκρο. Διακομίζεται (ώρα αναχώρησης: 16:10) με το ασθενοφόρο του ΚΥ στο νοσοκομείο.

Διακομίζεται προς: Το ΓΠΝ Τρίπολης (συνοδεία ιατρού και υπό συνεχές monitoring) για Ορθοπαιδική αντιμετώπιση του κατάγματος ΔΕ ισχίου, καθώς και για παθολογική και καρδιολογική διερεύνηση του αναφερόμενου συγκοπτικού επεισοδίου το οποίο οδήγησε στην κάκωση.

Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)



Ασκληπιάδης Ιπποκράτης
Ειδικός Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής,
Διευθυντής ΕΣΥ - ΚΥ Δημητσάνας.